



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : فوزيه مجلي قلاده ميخائيل
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : حلوان
رقم البطاقة : 27405200103264 رقم التليفون : 01224584844
العنوان : الجامع
العمر (تاريخ الميلاد) : 20-05-1974 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فوزيه مجلى قلاده ميخائيل National ID: 27405200103264	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

فوزيه
محلى فلاحه ميخائيل
١١ شل الجامع - منطوية ناصر - حدائق خلوان
خلوان - القاهرة

١٩٧٤/١٠/٢١ ٢٧٤.٥٢.٠١.٣٢٦٤
HY5948067

٢٠١٩/٠٣ ٢٧٤.٥٢.٠١.٣٢٦٤

بدون عمل
أنشى
مجدى حديد غريان ميخائيل
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٣/٢٥

١

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

فوزيه
مجلى قلاده ميخائيل
اش الجامع منشية ناصر - حدائق حلوان
حلوان - القاهرة

١٩٧١/٠٣
٢٧٤ ٠٥ ٢٠ ٠١ ٣٢ ٦٤
HY5948067

DMS
مقياس هاشم

٢٠١٩/٠٣ ٢٧٤ ٠٥ ٢٠ ٠١ ٣٢ ٦٤
بدون عمل
أنش
مجدى حديد عربان ميخائيل
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٣/١٥

١

26/12/2021

[illegible]

LY 555 + ALND: extension 0.3 cm + multiple foci of invasion
from LN 0/10
from lymph node

ADT OUTCOME & PLAN

SIGNATURE

Nutrition

[Signature]

1. **Answer:** *See above.*



قسم الباثولوجي

السن : 49 سنة

(2023) (2020 - 2023)

اسم المريض : فورية محلي فلاحه ميخائيل

محول من :

تاريخ الإسلام : 2023/10/21

تاريخ الحضور : 2023/10/17

NATURE OF SPECIMEN :

One paraffin block of cancer breast.

GROSS :

One paraffin block: sections immunostained for ER, PR, Her-2/neu, Ki67, using supersensitive monoclonal antibodies with En: Vision TM+ (HRP) detection system employing peroxidase after antigen retrieval and blocking internal peroxidase and using DAB as chromogen using BenchMark GX automated immunostainer.

MICROSCOPY :

Estrogen receptors : Strong nuclear staining in >80% of tumor cells .
Progesterone receptors: Strong nuclear staining in > 80% of tumor cells.
Her-2/neu : Weak incomplete membranous staining in <10% of tumor cells
Ki67: Positive nuclear staining in 10% of tumor cells.

DIAGNOSIS :

POSITIVE ESTROGEN RECEPTORS 8/8.
POSITIVE PROGESTERONE RECEPTORS 8/8.
NEGATIVE HER-2/neu, SCORE 1+
KI67 POSITIVE NUCLEAR STAINING IN 10% OF TUMOR CELLS.

RECOMENDATION :

2023/10/21



قسم الباثولوجي

قسم الباثولوجي

السن : 49 سنة

(2023) (3020 - 2023)

اسم المريض : فورية مجلى ولاده مختار

محل في :

تاريخ الاستلام : 2023/10/17

تاريخ الحصول : 2023/10/09

NATURE OF SPECIMEN :

Left breast mass core biopsy.

GROSS :

Multiple gray white tissue fragments collectively measured 2cm in long, totally submitted

MICROSCOPY :

Sections examined revealed invasive duct carcinoma (NST). The tumor form sheets, nests and cribriform pattern of moderate anaplastic ductal cells with moderate tendency to form tubules and occasional mitosis dispersed among desmoplastic stroma with focal necrotic change. Also seen intermediate grade ductal carcinoma insitu cribriform pattern represent 50% of the core submitted.

DIAGNOSIS :

Left breast mass core biopsy, INVASIVE DUCT CARCINOMA (NST) DUCTAL CARCINOMA INSITU, INTERMEDIATE GRADE 50% OF THE SUBMITTED MATERIAL

RECOMENDATION :

تاريخ

رقم البراءة : 27405200103264

تاريخ

Requester Name : الأمل / فوزية محمد / أمينة
Request No : 27405200103264
Ref No : 3923/23
Sex : Female
Age : 49 Y
Referring Doc :

Request No : 3001422
Request Date : 18/11/2023
Verification Date : 19/11/2023
Financial Code :
Department :
Registered by :
Dr. Heba Hasan
Dr. Heba Hasan

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer

Nature of the specimen : Left BCS & left ALN biopsy

Gross Examination:

- Procedure: Left BCS specimen measured 14x7x2 cm , covering skin 14x7 cm
- Tumor extent : A well defined greyish white firm mass measured 2.5x1.5x1.0 cm
- Distance from margins: (6,4,2.5,2.0,0.5, 0.5) cm away from (medial, lateral, superior, inferior, deep and skin margin , ,
- Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 5x1.5x1.0 cm
- ALNs up to 1.5x1 cm
- Frozen section: Free margins

Microscopic examination:

- Histological type: Extensive Ductal carcinoma in situ with multiple foci of invasion up to 2mm

Histological grade: High grade comedo & non comedo

Angioinvasion: No

Lymph node involvement: Free ALNs (0/19)

Resection Margins: Free margins

Diagnosis:

Left BCS & left ALN biopsy:

Extensive Ductal carcinoma in situ with multiple foci of invasion up to 2mm

Free LNs (0/19)

Free margins

Stage : pT1a , pN0

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Print Date : 02/12/2023 10:20:14

Page 1 of 2



Room No. (41) - First Floor - Building No. 987 - NHC Complex - Manama, Bahrain
Ministry of Health - National Laboratory for Women & Children - Manama, Bahrain

Prof. Dr. Gernot Abdelatty

Dr.Marwa Mahmoud

Log Date : 02/12/2023 10:20:14

Page 2 of 2



Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile City - Cairo - Egypt



Patient Name: Fawzeya Megally Kelada Mikhail	Date: 31/10/2023
Exam: MAMMOGRAPHY BOTH	Age: 49 Year(s)
Medical ID: 4114/2023	Pat. ID: 43528

**DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Indication:

Left breast palpable mass pathologically proven invasive ductal carcinoma with ductal carcinoma insitu.

Report:

- ACR a: scattered fibroglandular parenchyma.
- Bilateral foci of benign calcifications some are grouped
- Left Breast:
 - Irregular dense mass is seen in the UOQ measuring about 22x33mm.
 - Ultrasound shows this mass as irregular heterogenous lobulated mass. It is seen located at 1 to 2 o'clock, near the axillary tail 8mm from the skin.
 - No pathologically enlarged axillary lymph node are noted.
 - No supra or infraclavicular lymph node.
- Right Breast:
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Left breast pathologically proven malignant mass (BIRADS 6).
- Benign findings of right breast (BIRADS 2).

Best regards,
Dr Amal Ibrahim
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University

31/10 2023

Patient Name	Fawzia Megely Falah	Date	1/10/2023
--------------	------------------------	------	-----------

**BOTH BREAST SONOMAMMOGRAPHY EXAMINATION
REVEALED: -**

Mammography: -

- Heterogenous fibroglandular tissue of both breasts ACR C.
- Left UOQ less dense lobulated lesion measures about 2x2.5cm about 4cm from skin.
- No abnormal clusters of calcifications.
- Normal position of the nipples with intact overlying skin.
- Few bilateral axillary LNs.

Ultrasound: -

- Both breasts Show heterogeneous echogenicity with left breast axillary tail fairly defined lobulated hypoechoic lesion isv seen abutting underlying pectoralis muscle measures about 1x1.5x2cm about 1cm from skin surface.
- No evidence of dilated non dilated ducts are seen.
- Normal position of the nipples with intact overlying skin.
- Intact underlying pectoralis muscles.

Axillary US:

- Few bilateral non specific axillary LNs.

Opinion: -

- Left breast UOQ lobulated lesion BIRADS 4.

Recommendation:

- Core biopsy of left breast lesion.

Respectfully,
Dr. Samir Elghazaly, MSC.